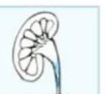


Douleurs abdominales

Anamnèse

1. Caractérisation de la douleur
 - a. Localisation
 - b. Irradiation
 - c. Chronologie
 - i. Début
 - ii. Circonstance de survenue
 - iii. Évolution (fluctuation)
 - d. Intensité
 - e. Qualité
 - f. Facteurs aggravants/soulageants
2. Symptômes associés
 - a. **Fièvre**
 - i. Début
 - ii. Intensité
 - iii. Fluctuation
 - b. **Frissons**, transpiration
 - c. **Perte de poids**, modification de l'appétit
 - d. Fatigue
 - e. Ictère
 - f. Vertige
3. Système digestif
 - a. Manger, boire ?
 - b. Nausée, vomissement
 - c. Selles
 - i. Consistance
 - ii. Fréquence, quantité
 - iii. Couleur
 - iv. Sang
 - v. Flottent – glaires
 - vi. **Dernières selles / derniers gaz**
4. Système urogénital
 - a. Douleur à la miction
 - b. Fréquence mictionnelle, quantité
 - c. Couleur
 - d. Sang dans l'urine
 - e. **Dernières règles si femme**
 - f. **Possibilité d'être enceinte ?**
 - g. **Perte vaginale si femme**
5. Antécédent
 - a. **Épisode similaire antérieur ?**
 - b. Maladie
 - c. Hospitalisation/opération
 - d. Médicaments
 - e. Allergie

Schmerztyp	Diagnose			
 Perforation	 Ulcusperforation	 Mesenterialinfarkt	 Gallenblasenperforation	
 Kolik	 Gallenkolik	 Uretersteinkolik	 Ileus	
 Entzündung	 Appendizitis	 Pankreatitis	 Cholezystitis	

Anamnèse gynécologique

6. Habitudes
 - a. Diète (contenu du dernier repas)
 - b. Alcool
 - c. Tabac
 - d. Drogues

Signes d'alarmes :

- État de choc
- Agitation, torpeur, conscience altérée
- Masse abdominale pulsatile
- État fébrile
- Ictère
- Déshydratation, oligo-anurie
- Dyspnée/tachypnée
- Rectorragies, méléna
- Âge > 65 ans
- Retard de règles
- Traumatisme récent

Examen clinique

1. Installation
 - a. **Bras et jambes décroisées**
 - b. Tête légèrement surélevée
 - c. Abdomen entièrement visible
2. Inspection
 - a. Visage : malaise, douleur
 - b. Peau : cicatrices, veines dilatées, lésions cutanées, vergetures...
 - c. Allure de l'abdomen : plat, arrondi, symétrie, voussure
 - d. Mouvements : respiratoire, péristaltique, pulsatiles
3. Auscultation (**avant palpation**)
 - a. 4 quadrants (fréquence gargouilles : 5-34/min)
 - b. Aorte
 - c. A. iliaque
4. Percussion
 - a. 4 quadrants
 - b. Délimite la taille du foie
5. Palpation (+ check visage patient, si résistance, le faire en expiration et en respirant par la bouche ouverte, mâchoire tombante)
 - a. 4 quadrants
 - i. Superficielle (1 main)
 - ii. Profonde (2 mains)
 - iii. Détente et défense
 - b. Palpation du foie
 - c. Palpation de la rate
 - d. Palpation des reins
 - e. Aorte (anévrisme)
 - f. Orifice herniaire

6. Tests spécifiques
 - a. Mc Burney
 - b. Signes du psoas
 - c. Signe de Murphy
7. Percussion des reins
8. **EVOQUER UN TOUCHER RECTAL + PALPATION AILES INGUINALES**

Examen complémentaire

- Fièvre, frisson → prise de sang
 - > 38.5 → hémoculture
- Hypochondre droit → ASAT, ALAT, gamma GT, phosphatase alcaline, bilirubine, albumine, TP/INR, marqueur inflammatoire, lipase
- Imagerie (CT, Rx, US...)
 - US :
 - Liquide libre abdominal
 - Anévrisme de l'aorte
 - Grossesse extra-utérine
 - Pathologie hépato-biliaire
 - Globe vésical, dilatation pyélo-calicienne
 - Appendicite
- Douleur épigastrique → ECG
- Hospitalisation ? antibiotique ? **antalgie** ?
- Coloscopie si
 - > 50 ans et douleur abdo
 - Bilan diarrhée
 - Bilan anémie

DD

- Douleur hypochondre droite
 - **Cholangite** (fièvre, douleur : murphy +, ictère)
 - **Angiocholite** (fièvre 39.5, frissons, ictère, secondairement à obstruction des voies biliaires)
 - **Hépatites aiguës** (ictère, douleur hypochondre D)
 - **Cholecystite** (si murphy +, pas d'ictère, crampiforme, fièvre)
 - **Cholédocholithiase** (douleur < 6h, pas de fièvre, déclenché par repas copieux, graisse, alcool, nausée vomissement, ictère, selles décolorées – urines foncées, pancréatite biliaire)
 - **Pancréatite** (douleur transfixiante)
 - **Abcès hépatiques**
 - **Thrombose veineuse**
 - **Insuffisance cardiaque droite** (nausée, vomissement, inappétence, hépatomégalie, constipation)
 - **Pneumonie** (souvent avec symptômes respiratoires, mais aussi nausée, vomissement)
 - **Pyélonéphrite**
- DD douleur hypochondre gauche
 - **Infarctus splénique**
 - **Abcès splénique**

- *Rupture splénique (rechercher traumatisme)*
- *Splénomégalie (chronique)*
- *Pneumonie (souvent avec symptômes respiratoires, mais aussi nausée, vomissement)*
- *Pyélonéphrite*
- DD douleur épigastrique et/ou périombilicale
 - **Infarctus du myocarde inférieur** (parfois vomissement, nausée)
 - **Dissection aortique** (douleur brutale en coup de couteau, transfixiante, douleur dans les jambes, souffle aortique diastolique)
 - **Pancréatite aiguë** (fièvre, douleur transfixiante, position en chien de fusil, iléus)
 - **Pancréatite chronique** (douleurs transfixiante, épisodes à répétition, intensité augmente, ictère, insuffisance exocrine : diarrhées - selles avec glaires, insuffisance endocrine : diabète)
 - **Ulcère gastrique** (douleur indépendante des repas, méléna, hématémèse, anémie, FR : alcool tabac, stress)
 - **Ulcère gastroduodénal** (amélioré par repas, douleur à jeun, méléna, hématémèse, anémie FR : stress, alcool, tabac)
 - **Gastrite** (fièvre, nausée-vomissement, satiété précoce)
 - **RGO** (brûlures épigastriques, régurgitation, nausée, satiété précoce, éructation, toux chronique)
- DD douleur au flanc
 - Origine uro-**génitale** :
 - **Colique néphrétique** (lithiase rénale : douleur au flanc qui irradie dans organes génitaux externes, coup de couteau, subite, diminué par l'application de chaud et par antalgique)
 - **Pyélonéphrite aiguë** (CT si pyélo compliquée)
 - Infarctus ou hématome rénal
 - Toute pathologie obstructive rénale
 - **Torsion testiculaire**
 - **Torsion ovarienne** (FR ovaire polykystique : pilosité augmentée, obésité, stérilité, acné)
 - Kyste ovarien
 - **Endométriose**
 - **Grossesse extra-utérine**
 - Origine digestive :
 - **Iléus** (ATCD chir abdo, pas de selles depuis qq jours, ni gaz, vomissement, miserere, pas de bruit = paralytique vs bruit métallique = mécanique)
 - **Maladie inflammatoire du tube digestif**
 - **Diverticulite**
 - Origine vasculaire :
 - Dissection aortique
 - Anévrisme
- DD douleur fosse iliaque
 - **Appendicite à droite** (para-ombilicale, secondairement en FID, rapidement croissante, vomissement, signe du psoas, Mc Burney)
 - **Diverticulite** (G >> D, péritonisme, fièvre)

- **Maladie de Crohn** (diarrhée chronique > 30j, perte de poids, sudation nocturne, sang dans les selles)
- **Colite ulcéreuse** (diarrhée chronique > 30j, perte de poids, sudation nocturne, sang dans les selles → réctorragies, ténésme, urgence, lithiase vésiculaire)
- *Iléite terminale*
- *Colite*
- *Affections gynécologiques*
- *Hématome du psoas (baisse TA)*
- DD douleur sus pubienne
 - *Cystite*
 - *Globe vésical (matité à la percussion, douleur à la palpation)*
 - **Affection gynécologique**

Autre

- *Colite infectieuse (anamnèse d'exposition = voyage, ballonnement, diarrhées glairo-sanglantes, perte de poids, fièvre)*
- *Côlon irritable (un jour par semaine durant les 3 derniers mois, douleur soulagée suite à selles, modification fréquence et consistance)*

Urgence

- **Péritonite** (< perf, ventre de bois, silence auscultatoire, fièvre)
 - CT + avis chir
- **Ischémie mésentérique** (empiré par repas, diarrhée glairo-sanglante, fièvre)
 - CT + avis chir
- **Occlusion** (abdo douloureux dans son ensemble, tympanisme, bruit métallique)
 - CT + avis chir
- **Rupture AA** (FR : homme, âge, tabac, HTA, douleur subite, irradiation dans le dos, état de choc)
 - US si instable ou CT si stable + avis chir
- **Grossesse extra-utérine** (amnénorrhée, douleurs abdo intenses, métrorragies)
 - Test de grossesse + US endovaginal

Douleurs abdominales aiguës : messages essentiels :

- Douleur abdominale d'origine incertaine → ECG à la recherche de SCA
- **Douleur abdominale chez une femme en âge de procréer → test de grossesse**
- Symptôme de colique néphrétique chez un patient de > 70 ans → suspecter un anévrisme de l'aorte (colique néphrétique inaugurale exceptionnelle au-delà de 70 ans)
- Signes d'alarmes : état de choc, péritonisme, ECG pathologique, traumatisme, test de grossesse + → hospitaliser le patient
- TRAITER LA DOULEUR